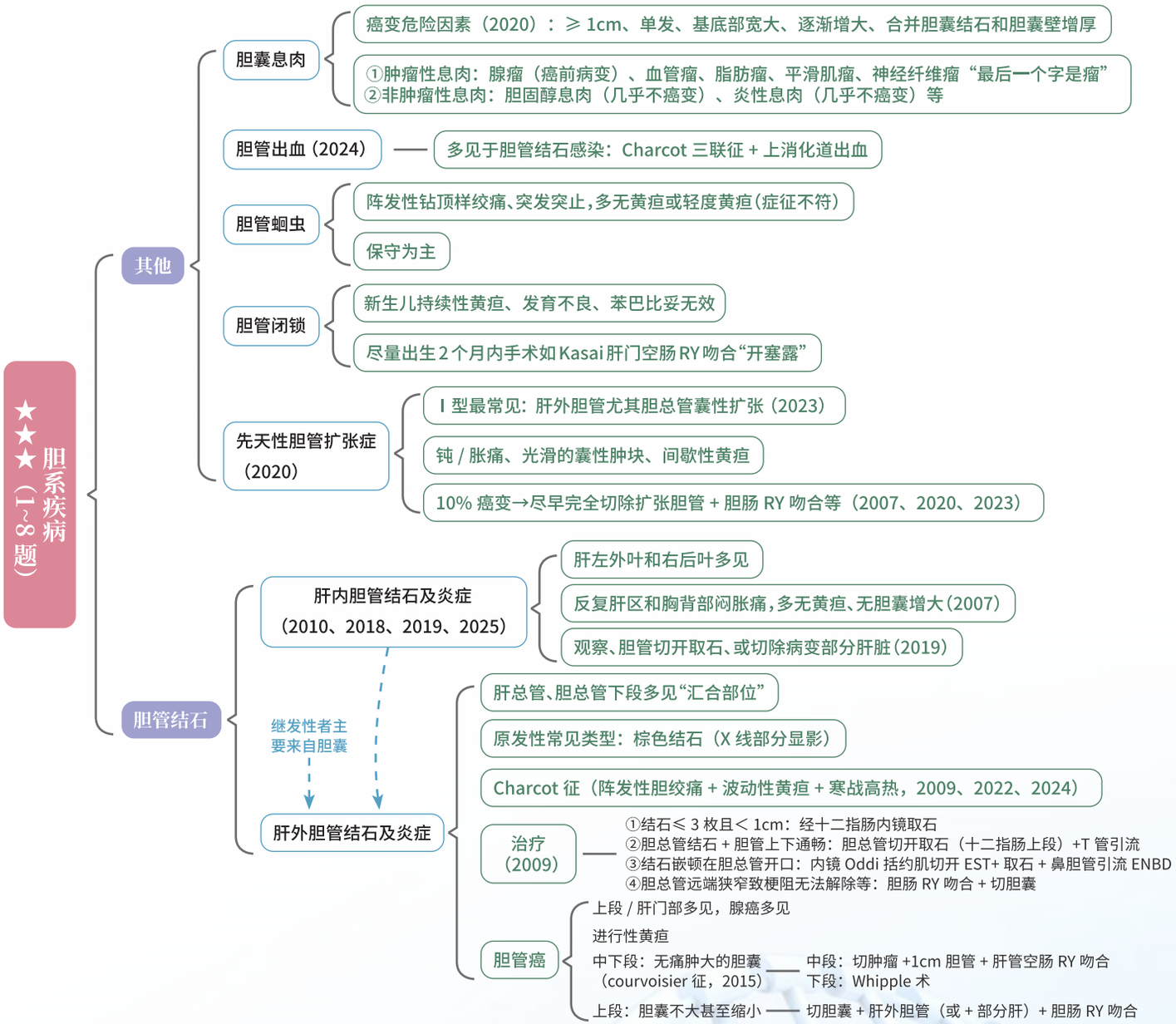

★★★胆系疾病（1~8题）
其他
胆囊息肉
癌变危险因素（2020）：≥ 1cm、单发、基底部宽大、逐渐增大、合并胆囊结石和胆囊壁增厚
①肿瘤性息肉：腺瘤（癌前病变）、血管瘤、脂肪瘤、平滑肌瘤、神经纤维瘤“最后一个字是瘤”
②非肿瘤性息肉：胆固醇息肉（几乎不癌变）、炎性息肉（几乎不癌变）等
胆管出血（2024）
多见于胆管结石感染：Charcot 三联征 + 上消化道出血
胆管蛔虫
阵发性钻顶样绞痛、突发突止，多无黄疸或轻度黄疸（症征不符）
保守为主
胆管闭锁
新生儿持续性黄疸、发育不良、苯巴比妥无效
尽量出生 2 个月内手术如 Kasai 肝门空肠 RY 吻合“开塞露”
先天性胆管扩张症（2020）
Ⅰ型最常见：肝外胆管尤其胆总管囊性扩张（2023）
钝 / 胀痛、光滑的囊性肿块、间歇性黄疸
10% 癌变→尽早完全切除扩张胆管 + 胆肠 RY 吻合等（2007、2020、2023）
胆管结石
肝内胆管结石及炎症（2010、2018、2019、2025）
肝左外叶和右后叶多见
反复肝区和胸背部闷胀痛，多无黄疸、无胆囊增大（2007）
观察、胆管切开取石、或切除病变部分肝脏（2019）
继发性者主要来自胆囊
肝外胆管结石及炎症
肝总管、胆总管下段多见“汇合部位”
原发性常见类型：棕色结石（X 线部分显影）
Charcot 征（阵发性胆绞痛 + 波动性黄疸 + 寒战高热，2009、2022、2024）
治疗（2009）
①结石≤ 3 枚且＜ 1cm：经十二指肠内镜取石
②胆总管结石 + 胆管上下通畅：胆总管切开取石（十二指肠上段）+T 管引流
③结石嵌顿在胆总管开口：内镜 Oddi 括约肌切开 EST+ 取石 + 鼻胆管引流 ENBD
④胆总管远端狭窄致梗阻无法解除等：胆肠 RY 吻合 + 切胆囊
胆管癌
上段 / 肝门部多见，腺癌多见
进行性黄疸
中下段：无痛肿大的胆囊（courvoisier 征，2015）
中段：切肿瘤 +1cm 胆管 + 肝管空肠 RY 吻合
下段：Whipple 术
上段：胆囊不大甚至缩小
切胆囊 + 肝外胆管（或 + 部分肝）+ 胆肠 RY 吻合